# Procedimiento de reporte de incidentes



## IDENTIFICACIÓN, OBJETIVO Y APLICABILIDAD

Procedimiento o manual de operación: Procedimiento de reporte de incidentes. Su finalidad es establecer trazabilidad, responsabilidades y evidencia verificable para la atención segura y la autoevaluación del consultorio.

**Aplicabilidad: VERIFICAR EN LA AUTOEVALUACIÓN POR SERVICIO Y MODALIDAD.**

Ámbito de uso: atención ambulatoria e infraestructura autorizada en el REPS; adaptar el contenido a las condiciones, recursos, modalidad y cartera de servicios efectivamente declarados.

## RESPONSABILIDADES DIFERENCIADAS

01. Responsable técnico: médico/a competente designado/a, sin nombre preimpreso.
02. Apoyo administrativo: custodiar la versión controlada y facilitar registros completos.
03. Prestador: disponer de evidencias reales, gestionar correcciones y verificar habilitación.
04. Usuarios: recibir información suficiente, participar en decisiones y reportar alertas.

## RIESGOS PRIORITARIOS DE CONTROL

01. Daño prevenible al paciente: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.
02. Falla del proceso: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.
03. Inconsistencia documental: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.
04. Ausencia de evidencia objetiva: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.

## REFERENTES NORMATIVOS PRINCIPALES

01. Decreto 780 de 2016 (SOGCS y régimen sectorial).
02. Resolución 3100 de 2019 y modificaciones aplicables (habilitación; manual anexo).
03. Resolución 2080 de 2026 (revocó la Resolución 1732 de 2026).
04. Ley 23 de 1981, arts. 15 y 34-36 (ética, consentimiento e historia clínica).
05. Resolución 1995 de 1999 y Resolución 839 de 2017 (historia clínica).

# Procedimiento de reporte de incidentes



## SECUENCIA DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO

APERTURA | Verificar que la versión esté vigente, que la actividad pertenezca al alcance autorizado y que el responsable tenga competencia documentada.

IDENTIFICACIÓN | Corroborar sede, usuario o equipo según corresponda; definir fecha, turno, servicio y código del registro.

VALORACIÓN | Identificar riesgos, barreras de seguridad, contraindicación o hallazgo que exige suspender o remitir.

EJECUCIÓN | Aplicar el procedimiento escrito, las instrucciones del fabricante si son pertinentes y los controles específicos de este documento.

CIERRE | Registrar el resultado objetivo, informar hallazgos, entregar recomendaciones y activar seguimiento en caso necesario.

MEJORA | Ante desviación, abrir acción correctiva, responsable, fecha de cierre y evaluación posterior de eficacia.

## VERIFICACIONES ESPECÍFICAS PARA ESTA ACTIVIDAD

01. Distinguir incidente sin daño, casi falla y evento adverso con daño; utilizar criterio y canal institucional.
02. Atender primero a paciente y activar tratamiento o remisión; no retrasar respuesta por trámites de reporte.
03. Documentar fecha, hecho objetivo, consecuencias, notificación y responsable de análisis de causas.
04. Seguir medidas correctivas y tendencias por frecuencia, gravedad y servicio; evitar señalar culpables sin análisis.
05. Corroborar aplicabilidad al servicio inscrito y a la modalidad real.
06. Asegurar recursos, insumos, responsabilidades y criterios de exclusión.
07. Ejecutar actividad con identificación inequívoca del usuario y registro seguro.

## CRITERIOS DE SUSPENSIÓN Y ESCALAMIENTO

Detener la actividad ante ausencia de competencia o autorización, condiciones inseguras, producto o equipo no conforme, negativa del paciente o signos clínicos de gravedad. Documentar la decisión y activar referencia cuando se necesite.

## INDICADORES DE CONTROL SUGERIDOS

Cumplimiento documental = registros completos / registros revisados x 100. Incidentes por actividad = incidentes notificados / actividades realizadas x 100. Ajustar metas a línea base y análisis de riesgo.

# Procedimiento de reporte de incidentes



## CONTROL OPERATIVO PARA DILIGENCIAR

Sede / consultorio:

Responsable de ejecución (sin prellenar):

Fecha de diligenciamiento y código del caso / equipo:

Actividad verificada, hallazgo y resultado:

## LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTADA

| Verificación | Sí | No | NA | Observación / soporte |
|---|---|---|---|---|
| Distinguir incidente sin daño, casi | [ ] | [ ] | [ ] | _____ |
| Atender primero a paciente y activa | [ ] | [ ] | [ ] | _____ |
| Documentar fecha, hecho objetivo, c | [ ] | [ ] | [ ] | _____ |
| Seguir medidas correctivas y tenden | [ ] | [ ] | [ ] | _____ |
| Corroborar aplicabilidad al servici | [ ] | [ ] | [ ] | _____ |

## HALLAZGOS Y GESTIÓN DE MEJORAS

Hallazgo / desviación identificada:

Acción, responsable y plazo acordado:

Evidencia de cierre / verificación de eficacia:

## CONTROL DE VALIDACIÓN INSTITUCIONAL

Elaboró: _____ Revisó: _____ Aprobó: _____

Fecha: _____ Versión: _____ Próxima revisión: _____

Firma del profesional responsable: _____